CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA I

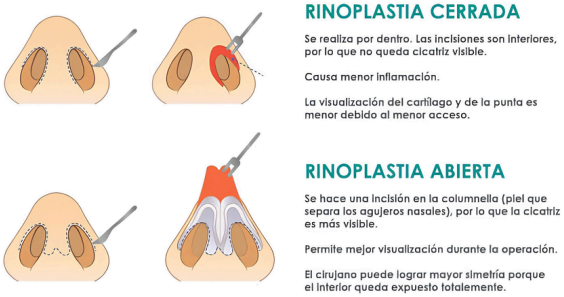
DR. JOSÉ AGUSTÍN ESPINO

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA ESPECIALIDAD

- Se ocupa de restaurar, reconstruir o mejorar la función y apariencia de estructuras afectadas por defectos congénitos, traumatismos, enfermedades o cirugías previas.
- Combina habilidades quirúrgicas avanzadas con un enfoque integral en el bienestar físico y emocional del paciente.
- Se divide en dos grandes categorías: estética y reconstructiva.

RINOPLASTIA Y BLEFAROPLASTIA: DETALLES

- Rinoplastia: puede ser abierta (incisión en columela) o cerrada (incisiones internas); modifica el dorso, la punta o la proyección nasal.
- Blefaroplastia: superior (exceso de piel) o inferior (bolsas de grasa); puede combinarse con cantopexia si hay flacidez del canto lateral.



CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA

- Se centra en mejorar la apariencia; no responde a una enfermedad sino al deseo estético del paciente.

CONSULTA Y EVALUACIÓN PREOPERATORIA

- Historia clínica completa, fotografías estandarizadas y, en procedimientos corporales, estabilidad del peso previa a la cirugía.
- Descartar contraindicaciones: tabaquismo activo, expectativas poco realistas, trastorno dismórfico corporal no tratado.

PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS MÁS FRECUENTES

- Rinoplastia: cambia forma/tamaño de la nariz. Blefaroplastia: cirugía de párpados, rejuvenece la mirada.
- Liposucción y abdominoplastia: remodelan el contorno corporal eliminando grasa y exceso de piel.
- Implantes mamarios y lifting facial/cuello: aumento mamario y rejuvenecimiento de los signos de la edad.



LIPOSUCCIÓN: TÉCNICA Y LÍMITES

- Técnica tumescente: infiltración de solución con lidocaína y epinefrina antes de aspirar la grasa, reduce sangrado y dolor.
- Volumen seguro por sesión: existe un límite de aspirado para evitar complicaciones sistémicas (embolismo graso, desequilibrio hidroelectrolítico).

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

- Se forman mediante programas de residencia tras la escuela de medicina.
- Base sólida en anatomía, técnicas quirúrgicas avanzadas y ética médica, cubriendo tanto lo estético como lo reconstructivo.

COMPLICACIONES GENERALES

- Hematoma, seroma e infección de la herida; asimetrías o resultados insatisfactorios que pueden requerir revisión.
- Sistémicas: trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, sobre todo en procedimientos combinados de larga duración.